PERÚ | Ministerio de Salud | Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC

Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio del Síndrome De Guillain Barré en el Perú









MINISTERIO DE SALUD

No. 675-2021/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 26 de Mayo del 2021

Visto, el Expediente N° 20-017011-002, que contiene la Nota Informativa N° 081-2020-CDC/MINSA, el Memorando N° 1436-2020-CDC/MINSA y la Nota Informativa N° 07-2020-SML-CDC/MINSA del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades; los Oficios N° 0192-2020-JEF-OPE/INS, N° 2558-2020-JEF-OPE/INS y la Nota Infamativa N° 1015-2020-CNSP/INS del Instituto Nacional de Salud; y, el Informe N° 451-2021-OGAJ/MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establecen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, el artículo 76 de la precitada Ley establece que la Autoridad de Salud de nivel nacional es responsable de dirigir y normar las acciones destinadas a evitar la propagación y lograr el control y erradicación de las enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional, ejerciendo la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria y dictando las disposiciones correspondientes;

Que, los numerales 1), 3) y 5) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, señala que el Ministerio de Salud es competente en salud de las personas, en epidemias y emergencias sanitarias y en inteligencia sanitaria, respectivamente;

Que, el artículo 4 del citado Decreto Legislativo dispone que el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, el numeral 4-A2 del artículo 4-A del acotado Decreto Legislativo, modificado por Decreto Legislativo Nº 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades, contempla que el Ministerio de Salud, ente rector del Sistema Nacional de Salud, y dentro del ámbito de sus competencias,

NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC

NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DEL SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN EL PERÚ

I. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La finalidad de la presente Norma Técnica de Salud es contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad de casos del Síndrome de Guillain Barré.

El Síndrome de Guillain Barré a nivel mundial es una enfermedad costosa, que puede resultar en discapacidad a largo plazo y altas tasas de mortalidad, especialmente en entornos de salud con recursos limitados. En el Perú, el Síndrome de Guillain Barré es considerado un evento de importancia en la salud pública y desde el año 2018, se ha estado notificando un incremento de casos mayor a lo esperado, reportándose en el año 2019 un incremento de gran magnitud que afectó a varios departamentos a nivel nacional.

La vigilancia de Síndrome de Guillain Barré fue establecida en el año 2016, en base a la captación de complicaciones por la enfermedad del zika. Sin embargo, habiendo transcurrido varios años desde su implementación, se ha evidenciado un comportamiento diferente de la enfermedad, nuevos conocimientos y otros posibles agentes etiológicos circulantes en el Perú para el Síndrome de Guillain Barré, que han generado la necesidad de elaborar una Norma Técnica de Salud para la vigilancia epidemiológica de Síndrome de Guillain Barré con un enfoque epidemiológico y laboratorial integrado.

II. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico para la detección temprana, investigación epidemiológica y monitoreo de brotes y de conglomerados de casos de Síndrome de Guillain Barré.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Establecer los procedimientos para la captación, registro, notificación, clasificación y análisis de casos de Síndrome de Guillain Barré.
b) Estandarizar los procedimientos de investigación epidemiológica de casos de Síndrome de Guillain Barré.
c) Establecer los procedimientos de obtención, conservación y transporte de muestras biológicas para el diagnóstico etiológico de los casos de Síndrome de Guillain Barré.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Norma Técnica de Salud es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel del Ministerio de Salud, de los Gobiernos Regionales, de los Gobiernos Locales, del Seguro Social de Salud (EsSalud), de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, del Instituto Nacional Penitenciario; así como en los establecimientos de salud privados

Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC
Norma Técnica De Salud para la Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio del Síndrome de Guillain Barré en el Perú

FINALIDAD

La finalidad de la presente Norma Técnica de Salud es contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad de casos del Síndrome de Guillain Barré.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico para la detección temprana, investigación epidemiológica y monitoreo de brotes y de conglomerados de casos de Síndrome de Guillain Barré.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ❑Establecer los procedimientos para la captación, registro, notificación, clasificación y análisis de casos de Síndrome de Guillain Barré.
- ❑Estandarizar los procedimientos de investigación epidemiológica de casos de Síndrome de Guillain Barré.
- ❑Establecer los procedimientos de obtención, conservación y transporte de muestras biológicas para el diagnóstico etiológico de los casos de Síndrome de Guillain Barré.

Fuente:NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

Ámbito de aplicación



La presente Norma Técnica de Salud es de aplicación *obligatoria* ***todos los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel*** *del atención en:*

- Ministerio de Salud
- Gobiernos Regionales, de los Gobiernos Locales
- Seguro Social de Salud (EsSalud)
- Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú
- Instituto Nacional Penitenciario
- Establecimientos de salud privados que desarrollen actividades relacionadas a la materia del presente documento normativo.

Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

Tipo de diagnóstico SGB

Tipo de Diagnostico SGB		Definición de caso
Caso Sospechoso de Síndrome de Guillain Barré	**Nivel de certeza III**	***Persona de cualquier edad con*** ❑Debilidad muscular bilateral (ascendente o descendente), simétrica o relativamente simétrica y ❑ Flacidez y ❑ Reflejos osteotendinosos disminuidos o ausentes en extremidades y ❑Con 12 horas a 28 días de evolución desde el inicio de la debilidad muscular.
Caso Confirmado de Síndrome de Guillain Barré	**Nivel de certeza II**	***Caso sospechoso*** con al menos uno de los siguientes criterios: • Disociación albumino citológica en Líquido Céfalo Raquídeo (Cifra total de leucocitos < 50 células/µl y elevación de proteínas > 45 mg/dl). O • Estudio electrofisiológico compatible con SGB tomada entre la segunda y cuarta semana de inicio de la debilidad muscular.
	Nivel de certeza I	***Caso sospechoso*** con los dos siguientes criterios: • Disociación albumino citológica en Líquido Céfalo Raquídeo (Cifra total de leucocitos < 50 células/µl y elevación de proteínas > 45 mg/dl). Y • Estudio electrofisiológico compatible con SGB tomada entre la segunda y cuarta semana de inicio de la debilidad muscular.
Caso descartado de Síndrome de Guillain Barré		***Caso sospechoso*** que durante la investigación tiene otro diagnóstico que explique el cuadro clínico, o que no cumpla con la definición de caso

Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

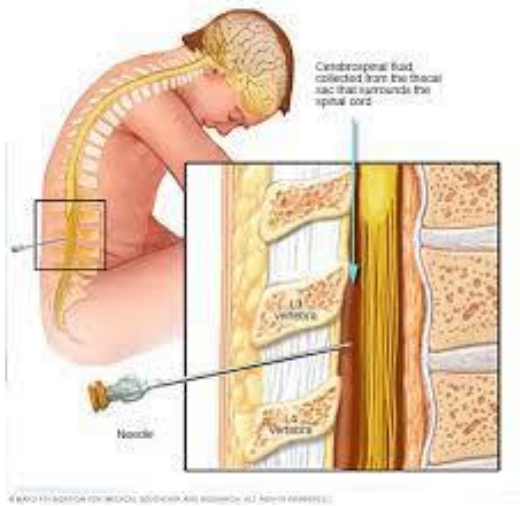
Confirmación de Caso de SGB DIFERENTE a Identificación etiológica

Acción	Prueba	Hallazgo
Confirmación del caso de Síndrome de Guillain Barré	**Punción Lumbar**	Disociación albumino citológica en Líquido Céfalo Raquídeo (Cifra total de leucocitos < 50 células/µl y elevación de proteínas > 45 mg/dl)
	Electromiografía	Estudio electrofisiológico compatible con SGB tomada entre la segunda y cuarta semana de inicio de la debilidad muscular.

Acción	Prueba	Hallazgo
Identificación de agente causal	La prueba a solicitar depende **del tiempo de debilidad muscular** y de los **antecedentes epidemiológico**	Positivo a agentes patológicos - Enterovirus - Campylobacter - Zika - Influenza A, B y subtipos, SARS-CoV-2 - Otros

Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

- La punción lumbar debe realizarse antes de la administración de inmunoglobulina; si fue obtenida durante el tratamiento y el resultado no muestra la disociación albumino citológica, opcionalmente se puede obtener una segunda muestra en la segunda semana desde el inicio de la debilidad muscular.
- La evaluación electrofisiológica es realizada entre la segunda y cuarta semana de inicio de la debilidad muscular, debiendo ser realizada por un profesional médico entrenado



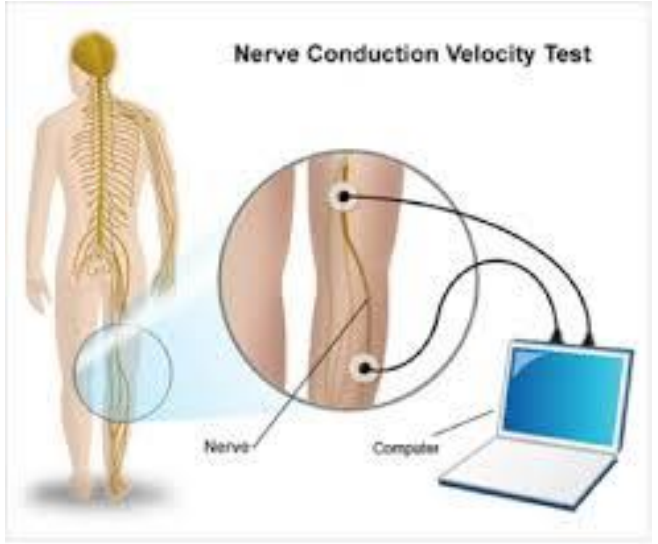


Fuente:NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

La electromiografía es una principales herramientas de apoyo para:

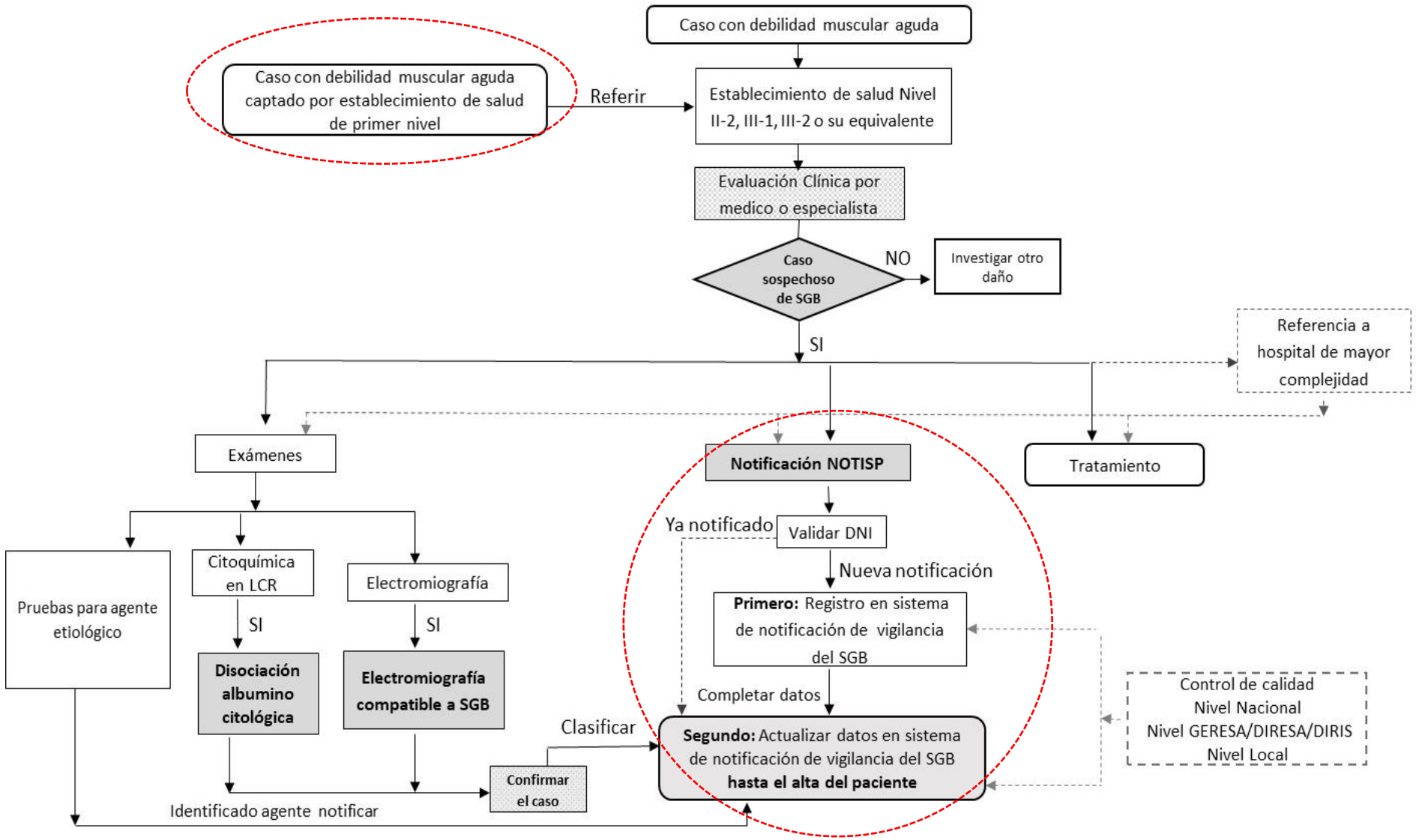
- ❑ Confirmar el diagnóstico,
- ❑ Determinar las variantes clínicas del SGB como:
  - ➢ Polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (siglas en ingles AIDP)
  - ➢ Neuropatía axonal motora aguda (siglas en ingles AMAN)
  - ➢ Neuropatía axonal sensorial motora aguda (siglas en ingles AMSAN)
  - ➢ Síndrome de Miller-Fisher





Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

ANEXO N°2 : FLUJOGRAMA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DEL SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ



Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

Tabla N° 1 Criterio para la obtención, conservación y transporte de muestras para Síndrome de Guillain Barré

Muestra	Prueba	Patógeno	Cantidad	Tiempo de enfermedad para la toma de muestra	Medio de transporte	Conservación	Nivel de laboratorio	Tiempo de resultados
Heces	Cultivo de Enterovirus	Enterovirus	10 gr	Hasta 30 días	No requiere	2 a 8 °C	INS	30 días
	PCR Enterovirus	Enterovirus		Hasta 30 días	No requiere	2 a 8 °C	INS	3 días
	Cultivo/PCR *Campylobacter*	*Campylobacter*		24 horas	No requiere	2 a 8 °C	INS, LRR, establecimiento de salud con capacidad diagnóstica	7 días
Hisopado rectal	Cultivo/PCR *Campylobacter*	*Campylobacter*	2 tubos	24 horas	Cary blair	Ambiente	INS, LRR, establecimiento de salud con capacidad diagnóstica	7 días
LCR	Citoquímico de LCR**		1 mL	Al inicio del cuadro clínico	No requiere	2 a 8 °C	Hospital	2 horas
	Cultivo Enterovirus	Enterovirus	2 mL	Hasta 7 días	No requiere	2 a 8 °C	INS	30 días
	PCR Enterovirus	Enterovirus		Hasta 7 días	No requiere	2 a 8 °C	INS	3 días
	Cultivo viral	Zika	1 mL	Hasta 7 días	No requiere	2 a 8 °C	INS	30 días
	qRT-PCR	Zika		Hasta 7 días	No requiere	2 a 8 °C	INS, LRR, establecimiento de salud con capacidad diagnóstica	3 días
	ELISA IgM	Zika		Hasta 7 días	No requiere	2 a 8 °C	INS, LRR, establecimiento de salud con capacidad diagnóstica	3 días
	TAAN	Panel meningitis	0.5 mL	Hasta 7 días	No requiere	2 a 8 °C	INS, Hospitales de Nivel III e institutos especializados	24 horas
Hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo	qRT-PCR	Influenza A, B y subtipos, SARS-CoV-2	3 mL	Hasta 10 días después de cuadro respiratorio febril (38°C)	Medio de transporte viral	2 a 8 °C	INS, LRR, establecimiento de salud con capacidad diagnóstica	3 días
Suero	ELISA IgM	Zika	2 mL	No aplica	No requiere	2 a 8 °C	INS, LRR, establecimiento de salud con capacidad diagnóstica	3 días
Orina	qRT-PCR	Zika	2 mL	Hasta 7 días	No requiere	2 a 8 °C	INS, LRR, establecimiento de salud con capacidad diagnóstica	3 días

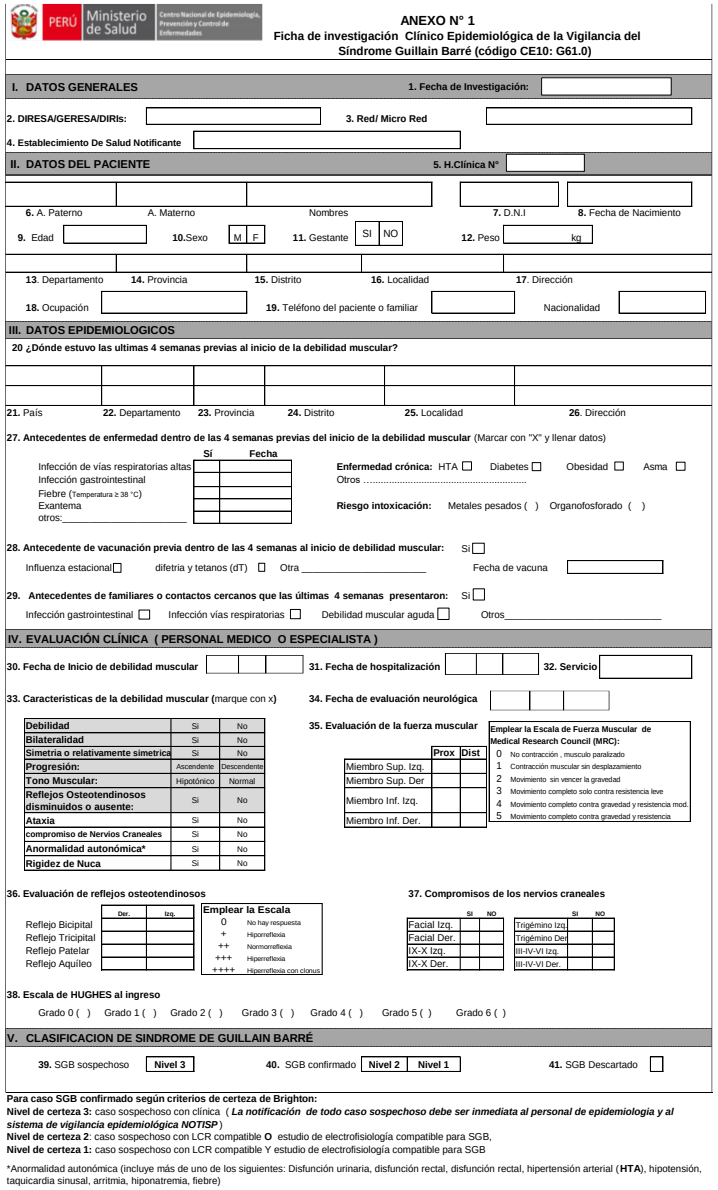
NOTA: * Laboratorios regionales con capacidad diagnostica, **La muestra de LCR para citoquímica es necesaria para la clasificación final de casos. La solicitud de la prueba debe ser registrada en la ficha clínico epidemiológica de síndrome de Guillain Barré. L**a *ficha original*** es de manejo del área de epidemiología y ***la copia*** de la ficha de manejo del área de laboratorio.
LCR: Líquido cefalorraquídeo; **PCR:** reacción en cadena de la polimerasa; **qRT-PCR**: Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa en tiempo real; **ELISA:** Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas; **TAAN:** Pruebas de amplificación de ácidos nucleicos; **INS**: Instituto Nacional de Salud; **LRR:** Laboratorio de Referencia Regional.
Fuente: Instituto Nacional De Salud. Manejo de muestras para pacientes con SGB

Fuente:NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

FICHA CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICA SGB

La ficha clínico epidemiológica cuenta con 10 secciones distribuidas en 2 hojas con 52 ítems

- **1era hoja:** Relacionada con la primera atención
- **2da hoja:** Relacionada al seguimiento del paciente y asociación con el virus zika



ANEXO N° 1
Ficha de investigación Clínico Epidemiológica de la Vigilancia del Síndrome Guillain Barré (código CE10: G61.0)

I. DATOS GENERALES — 1. Fecha de Investigación:
2. DIRESA/GERESA/DIRIs: — 3. Red/ Micro Red
4. Establecimiento De Salud Notificante

II. DATOS DEL PACIENTE — 5. H.Clínica N°
6. A. Paterno — A. Materno — Nombres — 7. D.N.I — 8. Fecha de Nacimiento
9. Edad — 10. Sexo (M / F) — 11. Gestante (SI / NO) — 12. Peso (kg)
13. Departamento — 14. Provincia — 15. Distrito — 16. Localidad — 17. Dirección
18. Ocupación — 19. Teléfono del paciente o familiar — Nacionalidad

III. DATOS EPIDEMIOLOGICOS
20 ¿Dónde estuvo las ultimas 4 semanas previas al inicio de la debilidad muscular?
21. País — 22. Departamento — 23. Provincia — 24. Distrito — 25. Localidad — 26. Dirección

27. Antecedentes de enfermedad dentro de las 4 semanas previas del inicio de la debilidad muscular (Marcar con "X" y llenar datos)

	Sí	Fecha
Infección de vías respiratorias altas		
Infección gastrointestinal		
Fiebre (Temperatura ≥ 38 °C)		
Exantema		
otros:_____		

Enfermedad crónica: HTA ☐ Diabetes ☐ Obesidad ☐ Asma ☐
Otros .....
Riesgo intoxicación: Metales pesados ( ) Organofosforado ( )

28. Antecedente de vacunación previa dentro de las 4 semanas al inicio de debilidad muscular: Si ☐
Influenza estacional ☐ difetria y tetanos (dT) ☐ Otra _____ Fecha de vacuna

29. Antecedentes de familiares o contactos cercanos que las últimas 4 semanas presentaron: Si ☐
Infección gastrointestinal ☐ Infección vías respiratorias ☐ Debilidad muscular aguda ☐ Otros_____

IV. EVALUACIÓN CLÍNICA (PERSONAL MEDICO O ESPECIALISTA)
30. Fecha de Inicio de debilidad muscular — 31. Fecha de hospitalización — 32. Servicio
33. Caracteristicas de la debilidad muscular (marque con x)

	Si	No
Debilidad	Si	No
Bilateralidad	Si	No
Simetria o relativamente simetrica	Si	No
Progresión:	Ascendente	Descendente
Tono Muscular:	Hipotónico	Normal
Reflejos Osteotendinosos disminuidos o ausente:	Si	No
Ataxia	Si	No
compromiso de Nervios Craneales	Si	No
Anormalidad autonómica*	Si	No
Rigidez de Nuca	Si	No

34. Fecha de evaluación neurológica
35. Evaluación de la fuerza muscular

	Prox	Dist
Miembro Sup. Izq.		
Miembro Sup. Der		
Miembro Inf. Izq.		
Miembro Inf. Der.		

Emplear la Escala de Fuerza Muscular de Medical Research Council (MRC):
0 No contracción , musculo paralizado
1 Contracción muscular sin desplazamiento
2 Movimiento sin vencer la gravedad
3 Movimiento completo solo contra resistencia leve
4 Movimiento completo contra gravedad y resistencia mod.
5 Movimiento completo contra gravedad y resistencia

36. Evaluación de reflejos osteotendinosos

	Der.	Izq.
Reflejo Bicipital		
Reflejo Tricipital		
Reflejo Patelar		
Reflejo Aquíleo		

Emplear la Escala
0 No hay respuesta
+ Hiporreflexia
++ Normorreflexia
+++ Hiperreflexia
++++ Hiperreflexia con clonus

37. Compromisos de los nervios craneales

	SI	NO
Facial Izq.		
Facial Der.		
IX-X Izq.		
IX-X Der.		

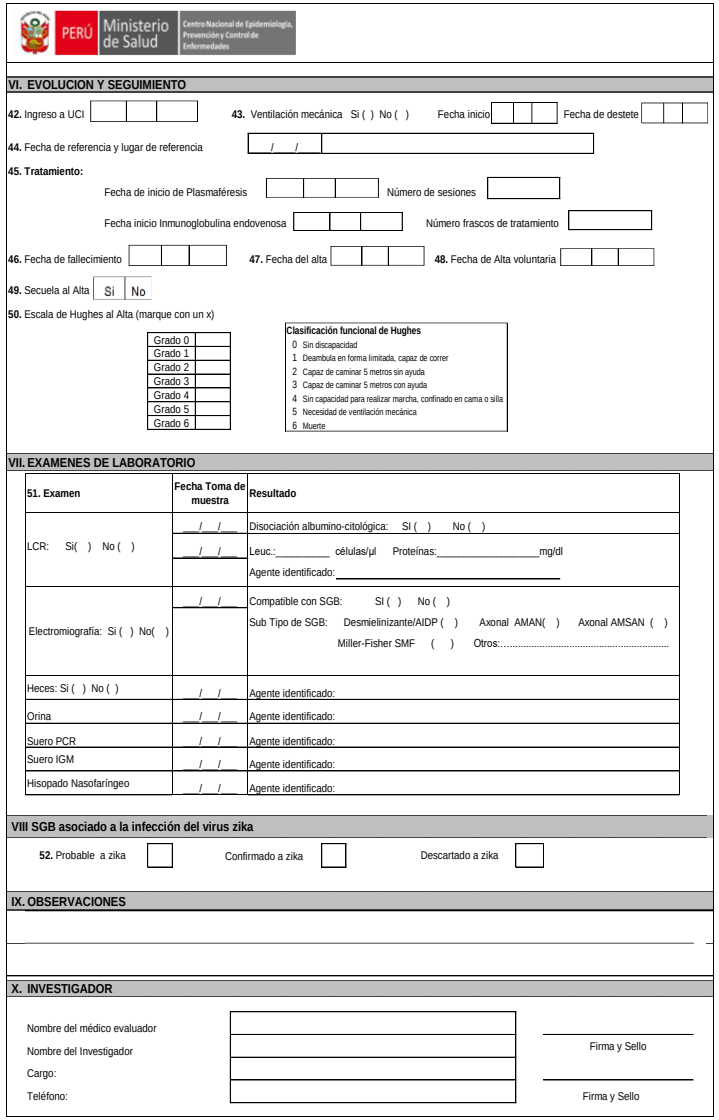
	SI	NO
Trigémino Izq.		
Trigémino Der.		
III-IV-VI Izq.		
III-IV-VI Der.		

38. Escala de HUGHES al ingreso
Grado 0 ( ) Grado 1 ( ) Grado 2 ( ) Grado 3 ( ) Grado 4 ( ) Grado 5 ( ) Grado 6 ( )

V. CLASIFICACION DE SINDROME DE GUILLAIN BARRÉ
39. SGB sospechoso [Nivel 3] — 40. SGB confirmado [Nivel 2] [Nivel 1] — 41. SGB Descartado ☐

Para caso SGB confirmado según criterios de certeza de Brighton:
Nivel de certeza 3: caso sospechoso con clínica (***La notificación de todo caso sospechoso debe ser inmediata al personal de epidemiología y al sistema de vigilancia epidemiológica NOTISP***)
Nivel de certeza 2: caso sospechoso con LCR compatible **O** estudio de electrofisiología compatible para SGB,
Nivel de certeza 1: caso sospechoso con LCR compatible Y estudio de electrofisiología compatible para SGB

*Anormalidad autonómica (incluye más de uno de los siguientes: Disfunción urinaria, disfunción rectal, disfunción rectal, hipertensión arterial (**HTA**), hipotensión, taquicardia sinusal, arritmia, hiponatremia, fiebre)



VI. EVOLUCION Y SEGUIMIENTO
42. Ingreso a UCI — 43. Ventilación mecánica Si ( ) No ( ) Fecha inicio — Fecha de destete
44. Fecha de referencia y lugar de referencia
45. Tratamiento:
Fecha de inicio de Plasmaféresis — Número de sesiones
Fecha inicio Inmunoglobulina endovenosa — Número frascos de tratamiento
46. Fecha de fallecimiento — 47. Fecha del alta — 48. Fecha de Alta voluntaria
49. Secuela al Alta (Si / No)
50. Escala de Hughes al Alta (marque con un x)

Grado 0	
Grado 1	
Grado 2	
Grado 3	
Grado 4	
Grado 5	
Grado 6	

Clasificación funcional de Hughes
0 Sin discapacidad
1 Deambula en forma limitada, capaz de correr
2 Capaz de caminar 5 metros sin ayuda
3 Capaz de caminar 5 metros con ayuda
4 Sin capacidad para realizar marcha, confinado en cama o silla
5 Necesidad de ventilación mecánica
6 Muerte

VII. EXAMENES DE LABORATORIO

51. Examen	Fecha Toma de muestra	Resultado
LCR: Si( ) No ( )	__/__/__	Disociación albumino-citológica: SI ( ) No ( )
	__/__/__	Leuc.:_____ células/µl Proteínas:_____mg/dl
		Agente identificado: _____
Electromiografía: Si ( ) No( )	__/__/__	Compatible con SGB: SI ( ) No ( )
		Sub Tipo de SGB: Desmielinizante/AIDP ( ) Axonal AMAN( ) Axonal AMSAN ( ) Miller-Fisher SMF ( ) Otros:.....
Heces: Si ( ) No ( )	__/__/__	Agente identificado:
Orina	__/__/__	Agente identificado:
Suero PCR	__/__/__	Agente identificado:
Suero IGM	__/__/__	Agente identificado:
Hisopado Nasofaríngeo	__/__/__	Agente identificado:

VIII SGB asociado a la infección del virus zika
52. Probable a zika ☐ Confirmado a zika ☐ Descartado a zika ☐

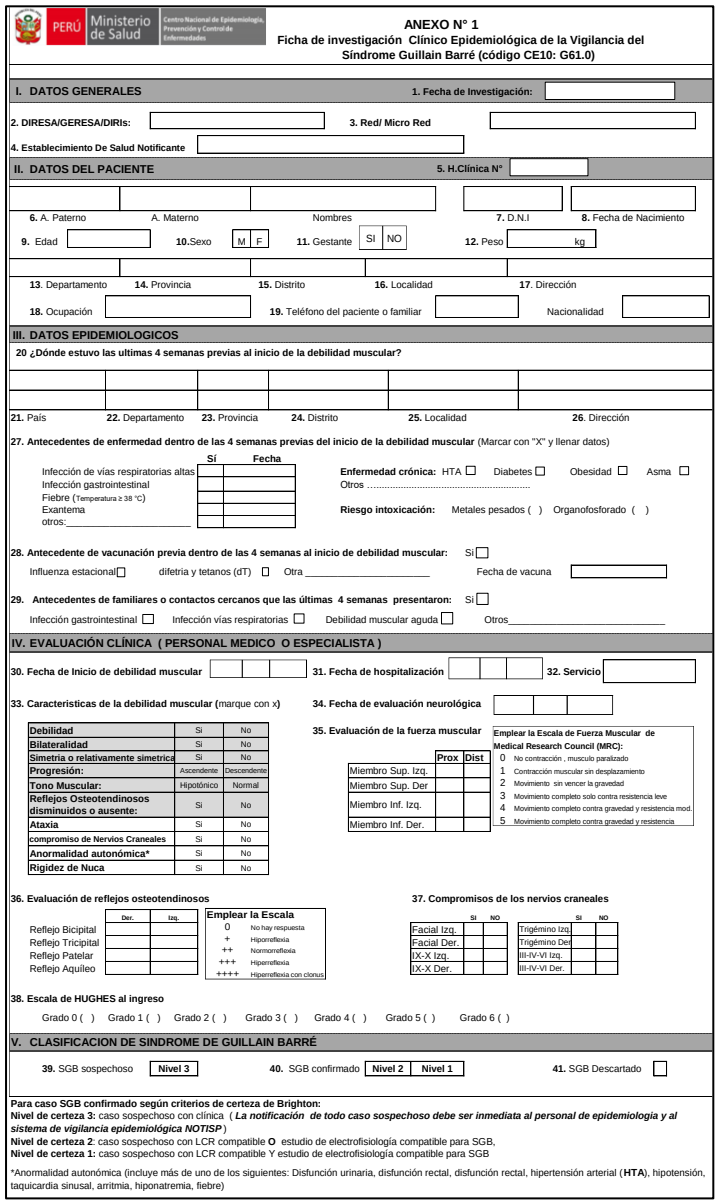
IX. OBSERVACIONES

X. INVESTIGADOR
Nombre del médico evaluador
Nombre del Investigador
Cargo:
Teléfono:
Firma y Sello
Firma y Sello

Todo menor de 15 años deberá adicionalmente contar con su muestra mínima de 10 gramos de heces para la vigilancia de Parálisis flácida SGB agudo desmielinizante (**AIDP**); SGB agudo axonal motora sensitiva aguda (**AMSAN**); SGB axonal motora aguda (**AMAN**)
micro litros (µl), miligramos por decilitro (mg/dl)

Fuente:NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

FICHA CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICA SGB



ANEXO N° 1
Ficha de investigación Clínico Epidemiológica de la Vigilancia del Síndrome Guillain Barré (código CE10: G61.0)

I. DATOS GENERALES — 1. Fecha de Investigación:

2. DIRESA/GERESA/DIRIs: — 3. Red/ Micro Red

4. Establecimiento De Salud Notificante

II. DATOS DEL PACIENTE — 5. H.Clínica N°

6. A. Paterno | A. Materno | Nombres | 7. D.N.I | 8. Fecha de Nacimiento

9. Edad | 10. Sexo (M / F) | 11. Gestante (SI / NO) | 12. Peso kg

13. Departamento | 14. Provincia | 15. Distrito | 16. Localidad | 17. Dirección

18. Ocupación | 19. Teléfono del paciente o familiar | Nacionalidad

III. DATOS EPIDEMIOLOGICOS

20 ¿Dónde estuvo las ultimas 4 semanas previas al inicio de la debilidad muscular?

21. País | 22. Departamento | 23. Provincia | 24. Distrito | 25. Localidad | 26. Dirección

27. Antecedentes de enfermedad dentro de las 4 semanas previas del inicio de la debilidad muscular (Marcar con "X" y llenar datos)

	Sí	Fecha
Infección de vías respiratorias altas		
Infección gastrointestinal		
Fiebre (Temperatura ≥ 38 °C)		
Exantema		
otros:_____		

Enfermedad crónica: HTA ☐ Diabetes ☐ Obesidad ☐ Asma ☐
Otros .....

Riesgo intoxicación: Metales pesados ( ) Organofosforado ( )

28. Antecedente de vacunación previa dentro de las 4 semanas al inicio de debilidad muscular: Si ☐
Influenza estacional ☐ difetria y tetanos (dT) ☐ Otra _____ Fecha de vacuna

29. Antecedentes de familiares o contactos cercanos que las últimas 4 semanas presentaron: Si ☐
Infección gastrointestinal ☐ Infección vías respiratorias ☐ Debilidad muscular aguda ☐ Otros_____

IV. EVALUACIÓN CLÍNICA (PERSONAL MEDICO O ESPECIALISTA)

30. Fecha de Inicio de debilidad muscular | 31. Fecha de hospitalización | 32. Servicio

33. Características de la debilidad muscular (marque con x)

Debilidad	Si	No
Bilateralidad	Si	No
Simetria o relativamente simetrica	Si	No
Progresión:	Ascendente	Descendente
Tono Muscular:	Hipotónico	Normal
Reflejos Osteotendinosos disminuidos o ausente:	Si	No
Ataxia	Si	No
compromiso de Nervios Craneales	Si	No
Anormalidad autonómica*	Si	No
Rigidez de Nuca	Si	No

34. Fecha de evaluación neurológica

35. Evaluación de la fuerza muscular

	Prox	Dist
Miembro Sup. Izq.		
Miembro Sup. Der		
Miembro Inf. Izq.		
Miembro Inf. Der.		

Emplear la Escala de Fuerza Muscular de Medical Research Council (MRC):
0 No contracción , musculo paralizado
1 Contracción muscular sin desplazamiento
2 Movimiento sin vencer la gravedad
3 Movimiento completo solo contra resistencia leve
4 Movimiento completo contra gravedad y resistencia mod.
5 Movimiento completo contra gravedad y resistencia

36. Evaluación de reflejos osteotendinosos

	Der.	Izq.
Reflejo Bicipital		
Reflejo Tricipital		
Reflejo Patelar		
Reflejo Aquileo		

Emplear la Escala
0 No hay respuesta
+ Hiporreflexia
++ Normorreflexia
+++ Hiperreflexia
++++ Hiperreflexia con clonus

37. Compromisos de los nervios craneales

	SI	NO
Facial Izq.		
Facial Der.		
IX-X Izq.		
IX-X Der.		

	SI	NO
Trigémino Izq.		
Trigémino Der.		
III-IV-VI Izq.		
III-IV-VI Der.		

38. Escala de HUGHES al ingreso
Grado 0 ( ) Grado 1 ( ) Grado 2 ( ) Grado 3 ( ) Grado 4 ( ) Grado 5 ( ) Grado 6 ( )

V. CLASIFICACION DE SINDROME DE GUILLAIN BARRÉ

39. SGB sospechoso [Nivel 3] — 40. SGB confirmado [Nivel 2] [Nivel 1] — 41. SGB Descartado ☐

Para caso SGB confirmado según criterios de certeza de Brighton:
Nivel de certeza 3: caso sospechoso con clínica (***La notificación de todo caso sospechoso debe ser inmediata al personal de epidemiologia y al sistema de vigilancia epidemiológica NOTISP***)
Nivel de certeza 2: caso sospechoso con LCR compatible **O** estudio de electrofisiología compatible para SGB,
Nivel de certeza 1: caso sospechoso con LCR compatible Y estudio de electrofisiología compatible para SGB

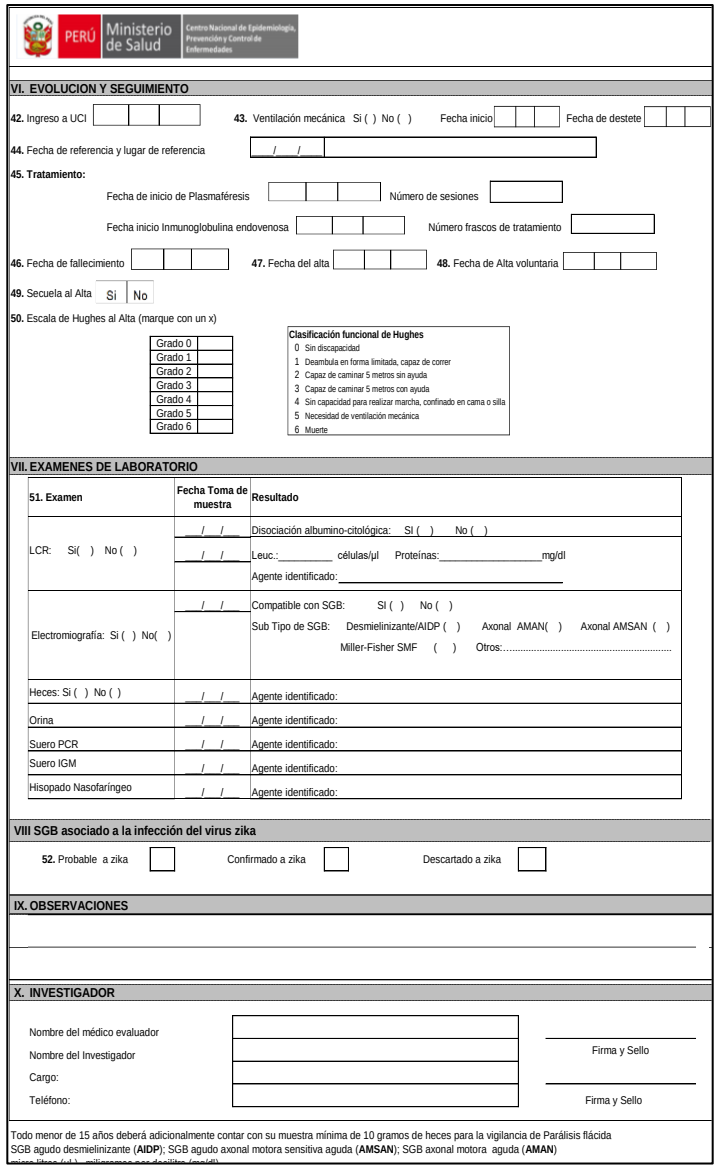
*Anormalidad autonómica (incluye más de uno de los siguientes: Disfunción urinaria, disfunción rectal, disfunción rectal, hipertensión arterial (**HTA**), hipotensión, taquicardia sinusal, arritmia, hiponatremia, fiebre)

- **1 era hoja: Consta con los ítems**

- I. Datos generales
- II. Datos del paciente
- III. Antecedentes epidemiológicos
- IV. Evaluación clínica
- V. Clasificación de síndrome de Guillain Barré

Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

FICHA CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICA SGB



PERÚ Ministerio de Salud — Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

VI. EVOLUCION Y SEGUIMIENTO

42. Ingreso a UCI | **43.** Ventilación mecánica Si ( ) No ( ) Fecha inicio | Fecha de destete

44. Fecha de referencia y lugar de referencia ___/___/___

45. Tratamiento:

Fecha de inicio de Plasmaféresis | Número de sesiones

Fecha inicio Inmunoglobulina endovenosa | Número frascos de tratamiento

46. Fecha de fallecimiento | **47.** Fecha del alta | **48.** Fecha de Alta voluntaria

49. Secuela al Alta Si | No

50. Escala de Hughes al Alta (marque con un x)

Grado 0	
Grado 1	
Grado 2	
Grado 3	
Grado 4	
Grado 5	
Grado 6	

Clasificación funcional de Hughes

0 Sin discapacidad
1 Deambula en forma limitada, capaz de correr
2 Capaz de caminar 5 metros sin ayuda
3 Capaz de caminar 5 metros con ayuda
4 Sin capacidad para realizar marcha, confinado en cama o silla
5 Necesidad de ventilación mecánica
6 Muerte

VII. EXAMENES DE LABORATORIO

51. Examen	Fecha Toma de muestra	Resultado
LCR: Si( ) No ( )	___/___/___	Disociación albumino-citológica: SI ( ) No ( )
	___/___/___	Leuc.:_____ células/µl Proteínas:_____mg/dl
		Agente identificado:_____
Electromiografía: Si ( ) No( )	___/___/___	Compatible con SGB: SI ( ) No ( )
		Sub Tipo de SGB: Desmielinizante/AIDP ( ) Axonal AMAN( ) Axonal AMSAN ( ) Miller-Fisher SMF ( ) Otros:.....
Heces: Si ( ) No ( )	___/___/___	Agente identificado:
Orina	___/___/___	Agente identificado:
Suero PCR	___/___/___	Agente identificado:
Suero IGM	___/___/___	Agente identificado:
Hisopado Nasofaríngeo	___/___/___	Agente identificado:

VIII SGB asociado a la infección del virus zika

52. Probable a zika | Confirmado a zika | Descartado a zika

IX. OBSERVACIONES

X. INVESTIGADOR

Nombre del médico evaluador — Firma y Sello

Nombre del Investigador

Cargo:

Teléfono: — Firma y Sello

Todo menor de 15 años deberá adicionalmente contar con su muestra mínima de 10 gramos de heces para la vigilancia de Parálisis flácida
SGB agudo desmielinizante (**AIDP**); SGB agudo axonal motora sensitiva aguda (**AMSAN**); SGB axonal motora aguda (**AMAN**)

- **2 da hoja: Consta con los ítems**

- VI. Evaluación y seguimiento
- VII. Exámenes de laboratorio
- VIII. SGB asociado al virus zika
- IX. Observaciones
- X. Investigador

Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

FICHA CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICA SGB

IV. EVALUACIÓN CLÍNICA (PERSONAL MEDICO O ESPECIALISTA)

30. Fecha de Inicio de debilidad muscular | | | |

31. Fecha de hospitalización | | | |

32. Servicio |

33. Caracteristicas de la debilidad muscular (marque con x)

Criterios clínicos relevantes

Debilidad	Si	No
Bilateralidad	Si	No
Simetria o relativamente simetrica	Si	No
Progresión:	Ascendente	Descendente
Tono Muscular:	Hipotónico	Normal
Reflejos Osteotendinosos disminuidos o ausente:	Si	No
Ataxia	Si	No
compromiso de Nervios Craneales	Si	No
Anormalidad autonómica*	Si	No
Rigidez de Nuca	Si	No

34. Fecha de evaluación neurológica | | |

35. Evaluación de la fuerza muscular

	Prox	Dist
Miembro Sup. Izq.		
Miembro Sup. Der		
Miembro Inf. Izq.		
Miembro Inf. Der.		

Emplear la Escala de Fuerza Muscular de Medical Research Council (MRC):

0 No contracción , musculo paralizado
1 Contracción muscular sin desplazamiento
2 Movimiento sin vencer la gravedad
3 Movimiento completo solo contra resistencia leve
4 Movimiento completo contra gravedad y resistencia mod.
5 Movimiento completo contra gravedad y resistencia

36. Evaluación de reflejos osteotendinosos

	Der.	Izq.
Reflejo Bicipital		
Reflejo Tricipital		
Reflejo Patelar		
Reflejo Aquíleo		

Emplear la Escala

0 No hay respuesta
+ Hiporreflexia
++ Normorreflexia
+++ Hiperreflexia
++++ Hiperreflexia con clonus

37. Compromisos de los nervios craneales

	SI	NO
Facial Izq.		
Facial Der.		
IX-X Izq.		
IX-X Der.		

	SI	NO
Trigémino Izq.		
Trigémino Der		
III-IV-VI Izq.		
III-IV-VI Der.		

38. Escala de HUGHES al ingreso

Grado 0 ( ) Grado 1 ( ) Grado 2 ( ) Grado 3 ( ) Grado 4 ( ) Grado 5 ( ) Grado 6 ( )

Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

V. CLASIFICACION DE SINDROME DE GUILLAIN BARRÉ

39. SGB sospechoso	**Nivel 3**		**40.** SGB confirmado	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**41.** SGB Descartado	

Para caso SGB confirmado según criterios de certeza de Brighton:

Nivel de certeza 3: caso sospechoso con clínica (***La notificación de todo caso sospechoso debe ser inmediata al personal de epidemiologia y al sistema de vigilancia epidemiológica NOTISP***)

Nivel de certeza 2: caso sospechoso con LCR compatible **O** estudio de electrofisiología compatible para SGB,

Nivel de certeza 1: caso sospechoso con LCR compatible Y estudio de electrofisiología compatible para SGB

*Anormalidad autonómica (incluye más de uno de los siguientes: Disfunción urinaria, disfunción rectal, disfunción rectal, hipertensión arterial (**HTA**), hipotensión, taquicardia sinusal, arritmia, hiponatremia, fiebre)

Fuente:NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

FICHA CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICA SGB

VI. EVOLUCION Y SEGUIMIENTO

42. Ingreso a UCI | | | | **43.** Ventilación mecánica Si ( ) No ( ) Fecha inicio | | | | Fecha de destete | | |

44. Fecha de referencia y lugar de referencia ___/___/___ |

45. Tratamiento:

Fecha de inicio de Plasmaféresis | | | | Número de sesiones |

Fecha inicio Inmunoglobulina endovenosa | | | | Número frascos de tratamiento |

46. Fecha de fallecimiento | | | | **47.** Fecha del alta | | | | **48.** Fecha de Alta voluntaria | | | |

49. Secuela al Alta | Si | No |

50. Escala de Hughes al Alta (marque con un x)

Grado 0	
Grado 1	
Grado 2	
Grado 3	
Grado 4	
Grado 5	
Grado 6	

Clasificación funcional de Hughes

0 Sin discapacidad
1 Deambula en forma limitada, capaz de correr
2 Capaz de caminar 5 metros sin ayuda
3 Capaz de caminar 5 metros con ayuda
4 Sin capacidad para realizar marcha, confinado en cama o silla
5 Necesidad de ventilación mecánica
6 Muerte

Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

FICHA CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICA SGB

Criterios relevantes para la conformación

VII. EXAMENES DE LABORATORIO

51. Examen	Fecha Toma de muestra	Resultado
LCR: Si( ) No ( )	___/___/___	Disociación albumino-citológica: SI ( ) No ( )
	___/___/___	Leuc.:_____ células/µl Proteínas:_____mg/dl
		Agente identificado:_____
Electromiografía: Si ( ) No( )	___/___/___	Compatible con SGB: SI ( ) No ( )
		Sub Tipo de SGB: Desmielinizante/AIDP ( ) Axonal AMAN( ) Axonal AMSAN ( )
		Miller-Fisher SMF ( ) Otros:.....
Heces: Si ( ) No ( )	___/___/___	Agente identificado:
Orina	___/___/___	Agente identificado:
Suero PCR	___/___/___	Agente identificado:
Suero IGM	___/___/___	Agente identificado:
Hisopado Nasofaríngeo	___/___/___	Agente identificado:

Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

FICHA CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICA SGB

VIII SGB asociado a la infección del virus zika					
52. Probable a zika	☐	Confirmado a zika	☐	Descartado a zika	☐

Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

Tipo de diagnósticos para zika

Tipo de Diagnóstico para zika	Probable
Caso SGB con asociación probable a zika	❑Caso de SGB que reside o ha visitado áreas con trasmisión activa de zika en los 30 días previos al inicio del cuadro clínico de SGB **Ó** ❑Caso de SGB que haya tenido contacto sexual sin protección con una persona con antecedente de residencia o viaje en las últimas 8 semanas a un área de transmisión activa de zika o tenga una prueba positiva para zika.
Caso SGB con asociación confirmada a zika	❑Caso de SGB con resultado laboratorial positivo de infección reciente para zika mencionado en la Norma Técnica Sanitaria N° 125-MINSA/2016/CDC-INS, “Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio de Dengue, Chikungunya, Zika y otras Arbovirosis en el Perú”2016 o las que haga sus veces.
Caso SGB con asociación descartada a zika	❑Caso de SGB con resultado laboratorial negativo a la enfermedad del virus zika10. ❑Caso de SGB con identificación de otro agente infeccioso (Campylobacter jejuni, citomegalovirus (CMV), Enterovirus, virus Ebstein Bar (VEB), VIH, dengue, chikungunya, SARS COV-2 u otros agentes bacterianos y virales) y no se demostró la enfermedad por virus zika.

Fuente:NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

En situación de brote o conglomerados de casos de SGB

Notificar de manera inmediata todo brote o conglomerado o incremento inusual

Búsqueda activa en servicios

Verificar el cumplimiento de la definición de los casos de SGB

Reporte diario de hospitalizados a través del aplicativo (actualizar datos en el sistema)

Investigación de los antecedentes de ***enfermedades respiratorias, digestivas agudas, infección viral o bacteriana, síndrome febril, exantema, exposición a órganos fosforado o metales pesados***, **4 semanas antes** del inicio de la debilidad muscular, entorno cercano y exposiciones comunes entre los casos del SGB notificados.

Cuando se sospeche de una exposición en común entre los casos del SGB, se deben tomar las pruebas para determinar etiología

Para casos del ***SGB relacionados a zika***, se debe considerar la definición de caso descrita anteriormente

Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

ANEXO N° 3

REPORTE DIARIO EN SITUACIÓN DE BROTES O CONGLOMERADOS DEL SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ

PERÚ | Ministerio de Salud | Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

HOSPITAL	Sector al que pertenece (MINSA/ EsSalud, FFAA, Privado)	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA	NOMBRE Y APELLIDO	EDAD	FECHA DE INICIO DE DEBILIDAD MUSCULAR	FECHA DE HOSPITALIZACIÓN	NOMBRE DEl HOSPITAL QUE NOTIFICA	TIPO DE DIAGNÓSTICO		SERVICIO	ALTA	FALLECIDO	REFERENCIA	HOSPITAL DE REFERENCIA	RECIBIO VENTILACIÓN MECÁNICA	RECIBIO TRATAMIENTO PASMAFÉRESIS	RECIBIO TRATAMIENTO INMUNOGLOBULINA
								SOSPECHOSO (Nivel de certeza 3)	CONFIRMADO (Nivel de certeza 1 y/o 2)								

Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

En situación de brote o conglomerados de casos de SGB

Generar una alerta epidemiológica

Evaluar la factibilidad de la toma de muestras de LCR y electromiografía a la totalidad de los casos

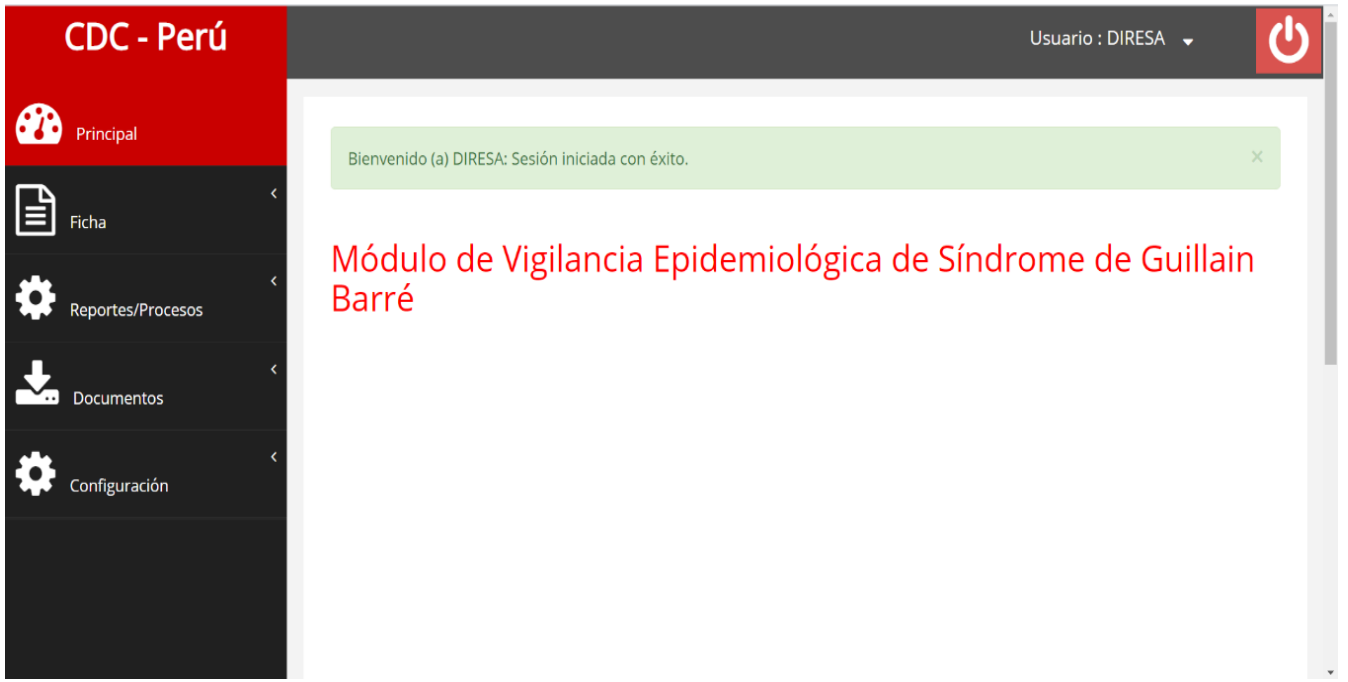
Puede generar protocolos de investigaciones epidemiológicas para determinar el agente etiológico

Se considera cierre de brote o disminución del número de casos conglomerados, cuando el número de casos del SGB notificados se encuentra en lo esperado.

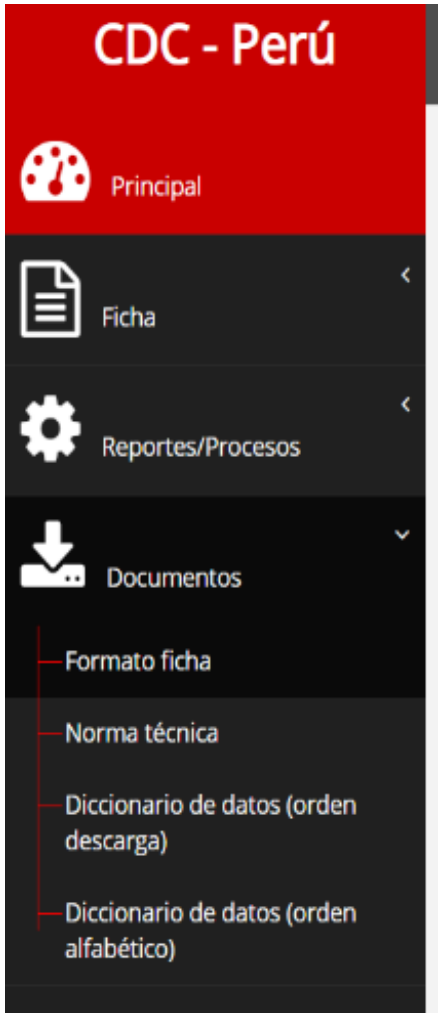
Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú

APLICATIVO WEB DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ





Fuente: CDC- modulo de vigilancia epidemiológica de síndrome de Guillain barré



El aplicativo cuenta con:

- Manual operativo
- Norma técnica aprobada
- Ficha clínico epidemiológica
- Diccionario de variable en orden de descarga
- Diccionario de datos en orden alfabética

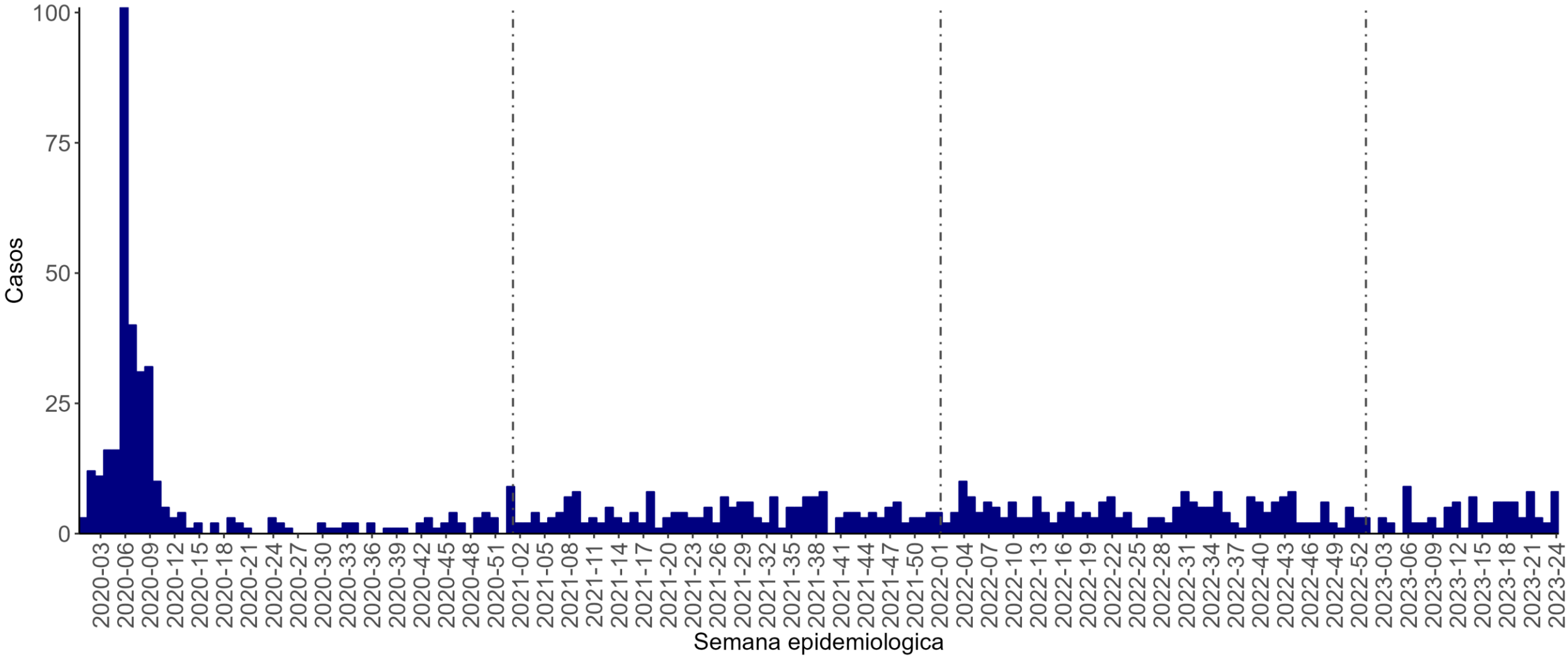
Fuente: CDC- modulo de vigilancia epidemiológica de síndrome de Guillain barré

Situación del síndrome de Guillain Barré Perú, 2023 (SE 25)

Unidad Técnica de Vigilancia de EDA/IRA/SGB, Influenza y OVR

(*Actualizado al 21/06/2023)

Tendencia de casos de Síndrome de Guillain Barré por semana epidemiológica 2020-2023 SE 25*



Hasta al 21 de junio 2023 /según fecha de inicio de debilidad

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA

Casos de Síndrome de Guillain Barré por departamentos de procedencia, Perú 2020- 2023 SE 25*

Departamento	2020		2021		2022		2023	
	N° (448)		N° (210)		N° (225)		N° (90)	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
AMAZONAS	0	0%	1	0.52%	2	0.93%	1	1.12%
ANCASH	11	2.81%	5	2.62%	5	2.31%	2	2.25%
APURIMAC	1	0.26%	3	1.57%	4	1.85%	2	2.25%
AREQUIPA	1	0.26%	2	1.05%	6	2.78%	2	2.25%
AYACUCHO	0	0%	1	0.52%	2	0.93%	1	1.12%
CAJAMARCA	23	5.87%	13	6.81%	20	9.26%	9	10.11%
CALLAO	27	6.89%	9	4.71%	10	4.63%	5	5.62%
CUSCO	5	1.28%	9	4.71%	9	4.17%	5	5.62%
HUANCAVELICA	3	0.77%	1	0.52%	1	0.46%	0	0%
HUANUCO	1	0.26%	6	3.14%	1	0.46%	1	1.12%
ICA	2	0.51%	6	3.14%	5	2.31%	1	1.12%
JUNIN	50	12.76%	9	4.71%	16	7.41%	5	5.62%
LA LIBERTAD	47	11.99%	12	6.28%	15	6.94%	16	17.98%
LAMBAYEQUE	11	2.81%	3	1.57%	4	1.85%	0	0%
LIMA	143	36.48%	77	40.31%	69	31.94%	25	28.09%
LORETO	1	0.26%	5	2.62%	6	2.78%	4	4.49%
MADRE DE DIOS	0	0%	1	0.52%	2	0.93%	0	0%
PASCO	1	0.26%	1	0.52%	1	0.46%	0	0%
PIURA	61	15.56%	19	9.95%	17	7.87%	7	7.87%
PUNO	0	0%	3	1.57%	3	1.39%	0	0%
SAN MARTIN	1	0.26%	5	2.62%	9	4.17%	2	2.25%
TACNA	1	0.26%	0	0%	4	1.85%	0	0%
TUMBES	2	0.51%	0	0%	3	1.39%	1	1.12%
UCAYALI	0	0%	0	0%	2	0.93%	0	0%

Hasta al 21 de junio 2023

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA

Características de los casos de Síndrome de Guillain Barré, 2020 - 2023 (SE 25*)

Características		2020		2021		2022		2023	
		N° (448)		N° (210)		N° (225)		N° (90)	
		N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Curso de vida	Nino	28	6.25%	19	9.05%	28	12.44%	16	17.78%
	Adolescente	29	6.47%	13	6.19%	13	5.78%	4	4.44%
	Joven	71	15.85%	34	16.19%	30	13.33%	9	10%
	Adulto	219	48.88%	103	49.05%	100	44.44%	35	38.89%
	Adulto Mayor	101	22.54%	41	19.52%	54	24%	26	28.89%
Sexo	F	144	32.14%	82	39.05%	83	36.89%	41	45.56%
	M	304	67.86%	128	60.95%	142	63.11%	49	54.44%

Hasta al 21 de junio 2023

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MI

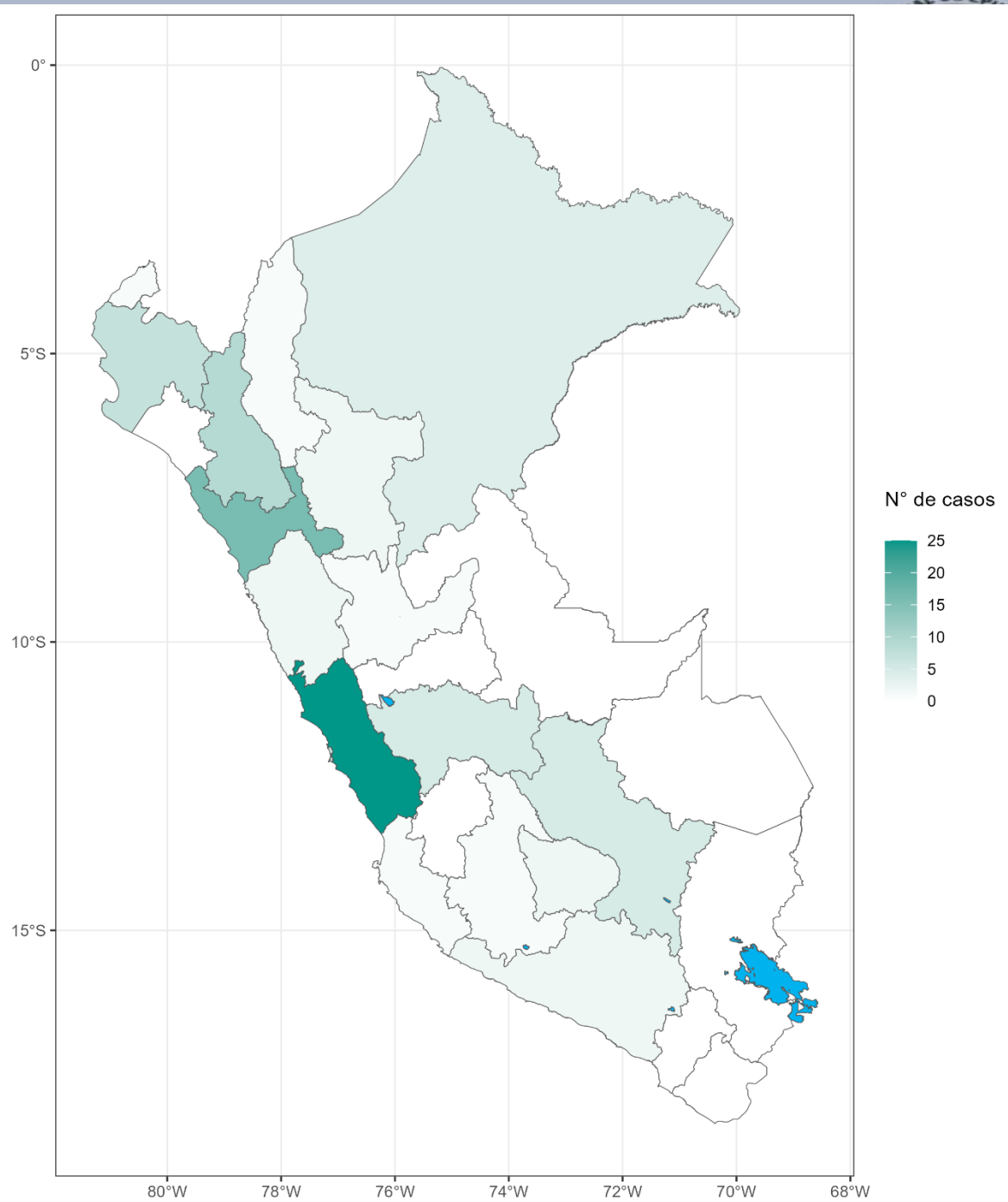
Características de los casos de Síndrome de Guillain Barré, 2020 - 2023 (SE 25*)

Características		2020 N° (448)		2021 N° (210)		2022 N° (225)		2023 N° (90)	
		N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Ant. enf. previas	Inf. Respiratoria	75	--	46	--	56	--	26	--
	Inf. Gastrontestinal	134	--	40	--	52	--	18	--
	Febril	52	--	35	--	20	--	12	--
	Exantema	3	--	3	--	1	--	0	--
	Sin dato	158	--	76	--	87	--	32	--
Progesión	Ascendente	263	58.71%	153	72.86%	150	66.67%	63	70%
	Descendente	129	28.79%	33	15.71%	38	16.89%	17	18.89%
	Sin dato	56	12.5%	24	11.43%	37	16.44%	10	11.11%
Comorbilidad	Hipertensión Arterial	30	--	19	--	31	--	16	--
	Diabetes	13	--	9	--	21	--	4	--
	Obesidad	3	--	3	--	13	--	7	--
	Asma	5	--	3	--	3	--	2	--
	Otros	266	--	86	--	18	--	6	--
	Sin dato	266	--	88	--	64	--	26	--
Secuela	Si	0	0%	6	2.86%	53	23.56%	14	15.56%
	No	0	0%	16	7.62%	45	20%	2	2.22%
	Sin dato	448	100%	188	89.52%	127	56.44%	74	82.22%
Nivel de certeza	Nivel 1	33	7.37%	16	7.62%	25	11.11%	9	10%
	Nivel 2	58	12.95%	38	18.1%	84	37.33%	26	28.89%
	Nivel 3	55	12.28%	67	31.9%	116	51.56%	55	61.11%
	Sin dato	302	67.41%	89	42.38%	0	0%	0	0%
Subtipo de SGB	AIDP	15	3.35%	5	2.38%	16	7.11%	7	7.78%
	AMAN	25	5.58%	0	0%	12	5.33%	4	4.44%
	AMSAN	2	0.45%	2	0.95%	6	2.67%	5	5.56%
	Miller-Fisher SMF	1	0.22%	2	0.95%	0	0%	1	1.11%
	Otros	52	11.61%	50	23.81%	4	1.78%	1	1.11%
	Sin dato	353	78.79%	151	71.9%	187	83.11%	72	80%

Hasta al 21 de junio2023

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA

Casos de Síndrome de Guillain Barré por lugar de procedencia, Perú 2023 SE 25*



Hasta al 21 de junio 2023

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica C

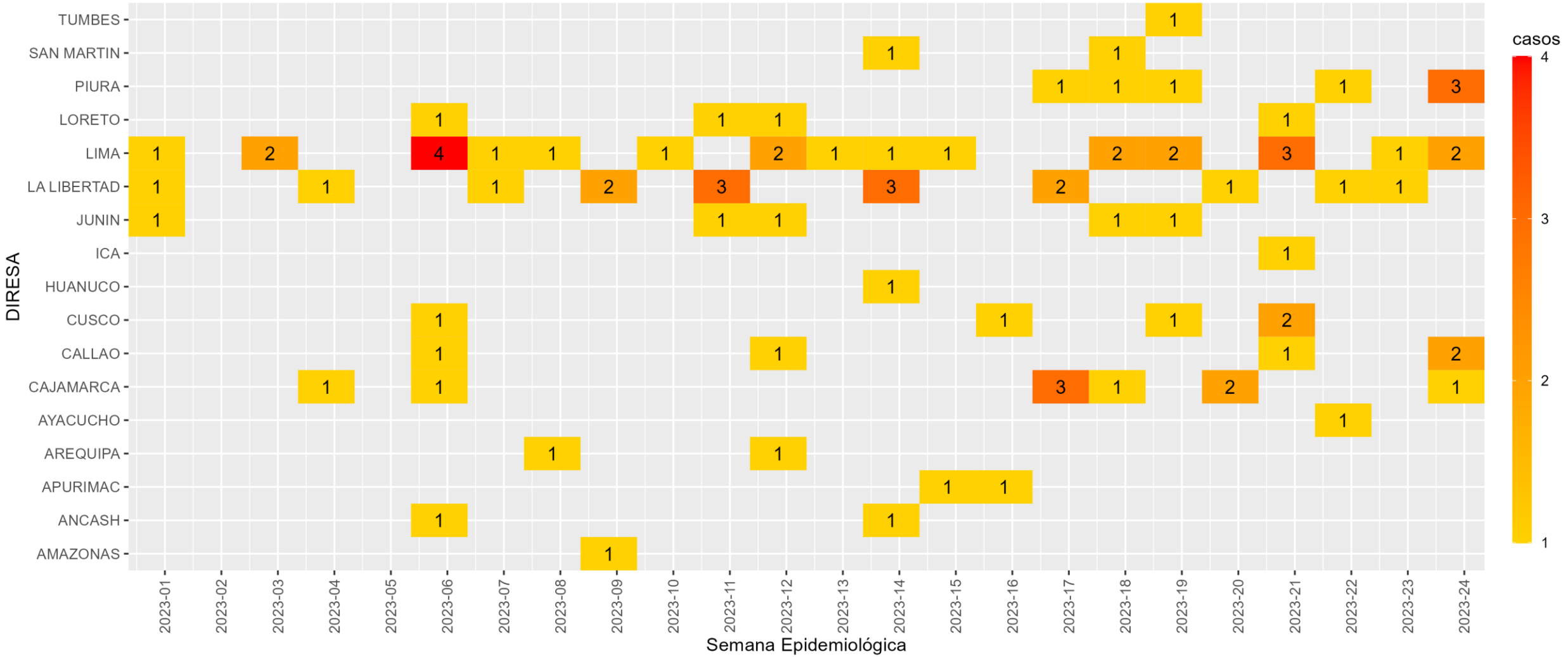
Clasificación de los casos de Síndrome de Guillain Barré, 2023 (SE 25*)

Departamento	Total			Confirmados		Sospechosos		Defunción
	N°	%	TIA	N°	%	N°	%	N°
AMAZONAS	1	1.11%	2.3	0	0%	1	1.82%	0
ANCASH	2	2.22%	1.7	1	2.86%	1	1.82%	0
APURIMAC	2	2.22%	4.6	0	0%	2	3.64%	0
AREQUIPA	2	2.22%	1.3	2	5.71%	0	0%	0
AYACUCHO	1	1.11%	1.5	1	2.86%	0	0%	0
CAJAMARCA	9	10%	6.2	5	14.29%	4	7.27%	1
CALLAO	5	5.56%	4.2	1	2.86%	4	7.27%	0
CUSCO	5	5.56%	3.6	0	0%	5	9.09%	0
HUANUCO	1	1.11%	1.3	0	0%	1	1.82%	0
ICA	1	1.11%	1	0	0%	1	1.82%	0
JUNIN	5	5.56%	3.6	3	8.57%	2	3.64%	0
LA LIBERTAD	16	17.78%	7.6	5	14.29%	11	20%	1
LIMA	25	27.78%	2.2	17	48.57%	8	14.55%	1
LORETO	4	4.44%	3.8	0	0%	4	7.27%	0
PIURA	7	7.78%	3.3	0	0%	7	12.73%	0
SAN MARTIN	2	2.22%	2.1	0	0%	2	3.64%	0
TUMBES	1	1.11%	3.8	0	0%	1	1.82%	0
Total	89	-	-	35	-	54	-	3

*Hasta al 21 de junio2023

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA

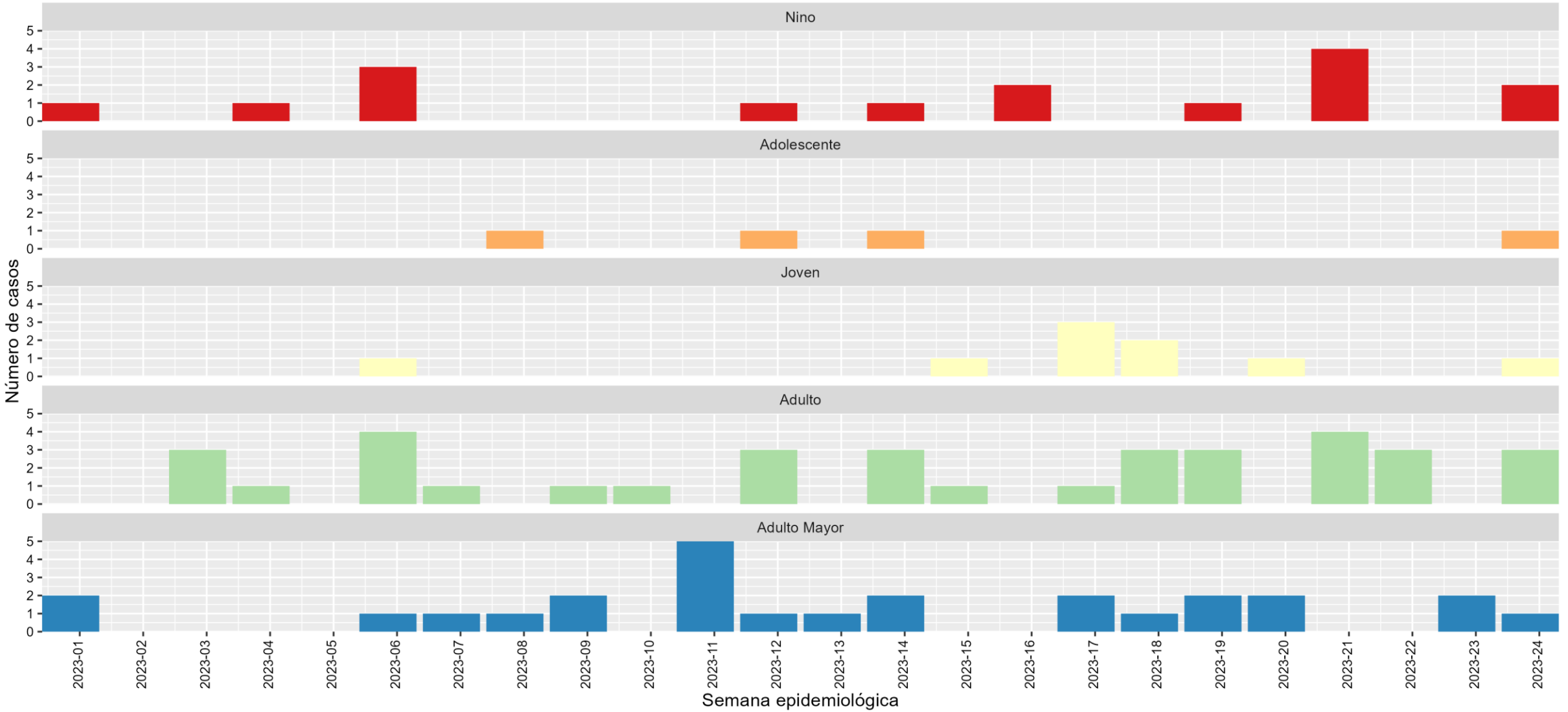
Casos de Síndrome de Guillain Barré por semana epidemiológica según procedencia, 2023 SE 25*



*Hasta al 21 de junio 2023

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA

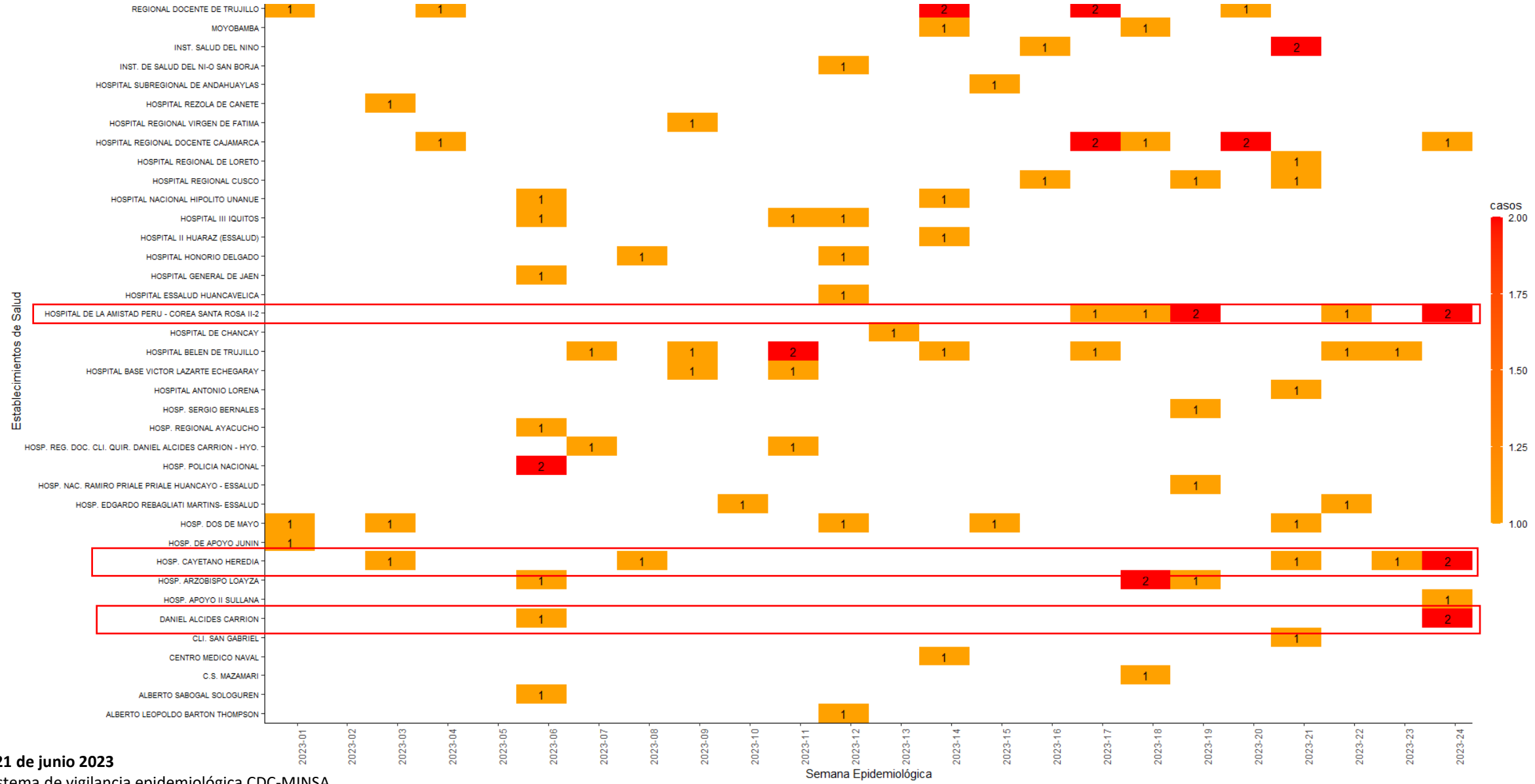
Tendencia de casos de Síndrome de Guillain Barré por curso de vida, 2023 SE 25*



*Hasta al 21 de junio 2023

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA

Casos de Síndrome de Guillain Barré por semana epidemiológica según establecimiento de hospitalización, 2023 SE 25*



Hasta al **21 de junio 2023**

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA

Recomendaciones

- ✓ Todo caso sospechoso debe ser en un plazo de 4 semanas de notificado.
- ✓ Los casos que no cuenten con muestras de LCR para estudio de citoquímica o electromiografía deben tener obligatoriamente una evaluación neurológica y cumplir con la definición de caso sospechoso (Nivel 3 de certeza diagnostica para SGB).
- ✓ Cuando el caso sea referido, el establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva (hospitales, clínicas e institutos especializados en neurología) debe realizar la clasificación final del caso. Las UNs deben coordinar permanentemente para el cumplimiento de la clasificación.
- ✓ Si el caso tuviera una muestra positiva a zika, se debe registrar también en el sistema de notificación de la vigilancia de arbovirosis.
- ✓ Es responsabilidad del personal de epidemiología quien notifica hacer el control de calidad, seguimiento a los resultados para citoquímica en LCR y electromiografía. Así como de los posibles agentes causales.
- ✓ Todo paciente menor de 15 años debe ser notificado e investigado en la vigilancia de parálisis flácida aguda y solicitar una muestra de heces.

Fuente: NTS Nº 175 - MINSA/2021/CDC Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio Del Síndrome De Guillain Barré En El Perú